Station 1

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Station 1 HLR - april 2023 Umeå, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontroll av medvetande (ruska om, ropa)	1	0
Kontroll av andning. Öppnar luftvägen och håller den öppen genom hela kontrollen	1	0
Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)	0.5	0
Larmar (på larmknapp i rummet, alt ropar på hjälp)	0.5	0
Utfört kompressioner med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört kompressioner med total medelhastighet 100-120/min	2	0
Utfört inblåsningar med minst 80% godkända	2.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 3

Arvid, 3 år kommer med sin mamma till barnmottagningen. Arvid drabbas ofta av förkylningar. Vid varje förkylning blir han ”pipig” i bröstet och kan inte sova - han hostar när han lägger sig och vaknar av hosta. Han är ”aldrig frisk” enligt mamman. Småhostar även mellan förkylningarna, särskilt när han springer och när det är kallt ute.
Arvid har även återkommande ett besvärligt eksem, framför allt lokaliserat i böjvecken.

I Arvids journal läser du att han senaste året sökt tre gånger på akuten för andningsbesvär. Vid samtliga tre tillfällen noteras i journalen att pojken ”har väsande andning och expiratoriska rhonki”.

Du ska:

- **Informera Arvids förälder om:**
    - **Mest trolig diagnos, förklara barnets besvär**
    - **Planerad behandling**

Station 3 Pediatrik - Arvid 3 år andningsbesvär, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Gör adekvat bedömning av Arvids symtom	1	0.5	0
Ställer diagnosen astma	1	- NA -	0
Beta-2-stimulerare: Förklarar effekten adekvat	1	0.5	0
Beta-2-stimulerare: Ordination vid behov	1	- NA -	0
Inhalationssteroid: Förklarar effekten adekvat	1	0.5	0
Inhalationssteroid: Regelbunden användning 1-2 gånger dagligen	1	- NA -	0
Informerar på föräldern fråga ”om kortison är farligt” att barn kan få hämmad längdtillväxt och att längden ska följas regelbundet	1	0.5	0
Informerar och förklarar för föräldern på ett begripligt sätt om inhalator/spacer	2	1	0
Hälsar och bemöter förälder på ett professionellt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 4

En 33-årig patient med långvariga axelledsbesvär kommer till dig på ortopedmottagningen.
Röntgen av axelled är utan anmärkning.

Du ska:

- **Göra en riktad kroppsundersökning** (berätta högt vad du gör)

- **Informera patienten om dina fynd och ge förslag på vidare handläggning och lämplig behandling**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Undersökning av rörlighet	2	1	0
Undersökning av instabilitet	2	1	0
Undersökning av impingement	2	1	0
Information om tillståndet	2	1	0
Förslag till behandling	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 5

Du är underläkare på kirurgmottagningen och har fått remiss från hälsocentralen gällande Lena, 70 år, som har haft intermittent värk i buken sista månaderna, gått ner 5 kg i vikt, har av och till haft ont i buken och noterat blodtillblandad avföring.

Du ska:

- **Undersöka buken (på dockan).** Berätta högt vad du gör.
- **Informera patienten om statusfynd, vilken diagnos som du misstänker och vidare handläggning**

En figurant spelar patient och en docka används för status.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tarmauskultation och inspektion av hela bukens form (utan filt)	1	- NA -	0
Systematisk och professionell palpation av hela buken	2	1	0
Bedömning av muskeltonus och ömhet	1	0.5	0
Identifikation av buktumör	1	- NA -	0
Informerar om undersökningsfynd på ett patientcentrerat sätt	2	1	0
Informerar patienten om coloskopi (eller CT colon+ rectoskopi), och vad det innebär för patienten	2	- NA -	0
Adekvat handläggningstakt	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 6

Du är jour och kallas till akutrummet där en 60-årig person inkommit med ambulans efter att ha svimmat under besök på en konstutställning.

Du ska:

- **Ta anamnes**
- **Föreslå vidare utredning**
- **Informera patienten om mest trolig orsak samt behandling**

Station 6 Kardiologi - Svimning pga AV III, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Ta en rimlig anamnes som ska innehålla aktuell sjukdom (tidigare infarkt), medicinering (betablockare) och aktuella symptom (ej bröstsmärta)	2	1	0
Efterfråga blodtryck och puls	1	- NA -	0
Efterfråga EKG och tolka det korrekt 0-1-2 p (ventrikulär rytm med bradykardi 1p; AV III 1 p)	2	1	0
Ringa bakjour och rapportera	1	- NA -	0

	4 poäng	3 poäng	2 poäng	1 poäng	0 poäng
Handläggning: närvarande, titta figuranten i ögon, lugna situationen, samtidigt planera för inläggning, telemetri, utsättande av betablockare och ev isoprenalin beredskap, planera för PM 1p: Relevant information, god kontakt med patient (figurant) 1p: Ordinera inläggning med telemetri 1p: Sätt ut metoprolol, ord isoprenalinberedskap 1p: PM trolig behandling	4	3	2	1	0
Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 7

Du är jour på ett mindre sjukhus. En oerfaren, men intresserad ny AT-läkare jobbar tillsammans med dig i kväll.
Du har skickat flera patienter till röntgen för akut undersökning.
Bilderna har nu kommit på tre av patienterna, men röntgensvaren dröjer.

Medan du väntar, gör du en egen tolkning av röntgenbilderna för att snabba på handläggningen. Det är bråttom, men du hinner också visa vad du har sett, och förklara hur du har tolkat bilderna för AT-läkaren.

Du ska:

- **Först själv bedöma tre olika röntgenundersökningar och välja ett av de föreslagna diagnos-alternativen till varje undersökning**
- **Sedan visa varje undersökning för AT-läkaren:**
  -Peka ut röntgenfyndet/fynden
  -Ange dess anatomiska förhållanden (läge/lokalisation)
  -Motivera hur du kommit fram till din valda diagnos

Du behöver inte logga in någonstans. Röntgenbilderna visas i form av en pdf på en bildskärm. Denna information finns även inne i rummet bredvid datorn.

Station 7 Röntgen - 3 fall, 26/04/2023 TEST 6 min Candidate:

Fall 1	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Trombotiserat bukaortaaneurysm =1p. Rupturerat bukaortaaneurysm = 0,5p. Övriga alternativ=0p.	1	0.5	0
Demonstration: Pekar ut aneurysmet + anger lokalisation i infrarenala bukaorta= 1p. Pekar ut aneurysmet men kan ej specificera lokalisation=0,5 p	1	0.5	0
Motiverar diagnosen: Vidgad aorta med lågattenuerande område kring kontrastförande lumen, dvs trombotisering ± negerar tecken på ruptur /blödning=1p. Kan ej förklara/motivera tecken på trombotisering men negerar tecken på ruptur/blödning=0,5p	1	0.5	0
Fall 2	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Malign hjärninfarkt =1p. Övriga alternativ=0p.	1	- NA -	0
Demonstration: Pekar ut infarktområdet + anger korrekt lokalisation (a. cerebri media dx försörjningsområde) ± visar dense media sign dx. =1p. Pekar ut infarktområdet men anger endast höger hemisfär eller fel sida =0,5p	1	0.5	0
Motiverar diagnosen: Utbrett lågattenuerande område motsv. a. cerebri medias försörjningsområde med utslätade fåror, tillklämning av höger sidoventrikel pga. ischemi och ödemutveckling/tecken på expansivt ödem=1p Anger att det finns ett lågattenuerande område men kan inte utveckla närmare = 0,5p.	1	0.5	0
Fall 3	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Fraktur i fibuladiafysen + frakturer i distala tibia: mediala och posteriora malleolerna. Instabil fotledsfraktur=2p. Fraktur i fibuladiafysen + frakturer i distala tibia: mediala och posteriora malleolerna. Stabil fotledsfraktur=1p. Bimalleolär fotledsfraktur: laterala och mediala malleolerna. Instabil fotledsfraktur=1p. Fraktur i tibiadiafysen + fraktur i distala fibula: mediala malleolen. Stabil fotledsfraktur=0p. Bimalleolär fotledsfraktur: laterala och mediala malleolerna. Stabil fotledsfraktur =0p.	2	1	0
Demonstration: Pekar ut alla 3 frakturlokalerna + anger korrekt lokalisation (diafys i fibula, medial och posterior malleol i tibia) =1 p Pekar ut och anger korrekt lokalisation på 2 av 3 frakturer=0,5p	1	0.5	0
Motiverar diagnosen: Kan argumentera korrekt för instabil fraktur (inkongruens i leden/syndesmosskada, noterar att frakturen är reponerad varför felställningen delvis hävd) och vet att en bi- eller trimalleolär fraktur per definition ÄR instabil) =1p. Resonerar godtagbart kring inkongruens i leden/syndesmosskada men kommer fram till att det är en stabil fraktur, tex. pga. man inte ser någon stor breddökning av fotledsgaffeln (noterar ej att frakturen är reponerad) eller saknar kunskap om att en bi- eller trimalleolär fraktur per definition ÄR instabil) = 0,5p.	1	0.5	0

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 9

Du är läkare på en hälsocentral och din nästa patient är en 35-årig individ med nydiagnostiserad hepatit C.

Patienten var trött och mådde illa för 2–3 veckor sedan och utreddes då med bland annat leverprover som var förhöjda. Din kollega ordinerade hepatitprov som visar att patienten har en akut och smittsam hepatit C. Patienten är inte informerad om detta.

Du ska:

- **Informera om vad hepatit C är för sjukdom och vad det innebär för patienten**
- **Ta en adekvat anamnes med fokus på epidemiologi och eventuell smittkälla för att kunna smittspåra!**
- **Svara på patientens frågor**

Du ska INTE göra kroppsundersökning med status eller ordinera provtagning.

Station 9 Infektion - Anamnestagning av patient med hepatit C, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp en strukturerad anamnes	1	- NA -	0
Tar reda på detaljer kring aktuella symtom (0,5p: Trötthet/ Illamående/Ikterus) och förlopp (0,5p: debut, duration förlopp)	1	0.5	0
Frågar om smittkälla och om epidemiologi (1p om minst 3 riskfaktorer; 2 p om minst 4) • Injektionsmissbruk? • Ev blodtransfusion? Blodgivare? • Kontakter med sjukvård, stickskada? • Utlandsvistelse • Sexuella kontakter senaste 2-6 månaderna? Tatuering?	2	1	0
Frågor om tidigare sjukhistoria och hepatitvaccination (0,5p var)	1	0.5	0
Frågar om yrke och social situation (0,5p var)	1	0.5	0
Ger tydlig information till patienten om hepatit C och hur det kan smitta.	2	- NA -	0
Patientcentrerat förhållningssätt Tillfredsställande (2p): God individcentrering. Visar tydligt att hen utgår ifrån patientens person i samtalet. Tar hänsyn till patientens signaler och frågar aktivt efter dennes uppfattning Ej tillfredsställande (0p): Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för patientens uppfattning.	2	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 10

Eva, 63 år kommer på kvällen till dig som onkologjour på akuten då hon senaste dagarna haft buksmärtor, illamående och kräkningar. Hon har en känd coloncancer med spridning till lungor och peritoneum. Idag har hon kräkts upp allt hon försökt äta och dricka, inklusive läkemedel. Känner sig trött och slut.

Allmäntillstånd: Vaken och orienterad. Temperatur 36,9 °C.
Blodtryck: 95/60 mmHg
Hjärta: Regelbunden rytm utan biljud. Puls 112 /minut.
Lungor: Rena andningsljud bilateralt utan biljud. Saturation 96% på luft.
Buk: Inga tarmljud hörs. Utspänd i övre delen av buken men inte hård. Oöm. Inga resistenser. Illamående vid palpation i epigastriet och under vänster arcus.

Aktuella läkemedel:
T. Dolcontin 10 mg × 2
T. Omeprazol 20 mg × 1

Du har beslutat att lägga in henne på vårdavdelning, men det finns få vårdplatser kvar på sjukhuset.

Du ska:

- **Rapportera patienten till ansvarig sjuksköterska på avdelningen**
- **Resonera kring de differentialdiagnoser du misstänker**
- **Ordinera åtgärder som ska göras under kvällen/natten**

Station 10 Onkologi - Akut onkologi, handläggning och ordination vid subileus/ileus, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sammanfattar fallet koncist och strukturerat	1	0.5	0
Står på sig om behovet av inläggning	1	0.5	0
Misstänker ileus/subileus	1	0.5	0
Ordinerar adekvat smärtlindring	1	0.5	0
Ordinerar blodprover (minst blodstatus, CRP, vätskestatus)	1	0.5	0
Ordinerar intravenös vätska	1	0.5	0
Ordinerar kontroll av puls, blodtryck och saturation	1	0.5	0
Ordinerar fasta och ventrikelsond	1	0.5	0
Beställer radiologi av buken	1	0.5	0
Kommunicerar lugnt och respektfullt med kollegan	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 11

En 14-årig pojke kommer till hälsocentralen på grund av lätt röda ögon och besvär med klåda och rinnande ögon.

Du ska:

- **Ställa in och använda ögonmikroskopet på samma sätt som om du skulle undersöka ett öga**
- **I stället för ett öga, finns ett kort med text. Du ska ställa in skärpan maximalt för att läsa texten**
- **När du läst texten, får du information om statusfynd**
- **Utifrån statusfynd ska du informera patienten om diagnos och vidare handläggning**

Station 11 Ögon - ögonmikroskopi; sjukdom i ögats främre del, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Ställa in okularen	1	- NA -	0
Slå på mikroskopet	1	- NA -	0
Ställa in spaltbredd och höjd	1	- NA -	0
Ställa in korrekt höjd	1	- NA -	0
Ställa in fokus med joysticken och klara att läsa kortet	1	- NA -	0
Slå av mikroskopet	1	- NA -	0
Ställa rätt diagnos	1	- NA -	0
Informera patienten på ett adekvat sätt (lättförståeligt, patientcentrerat)	1	- NA -	0
Sätta in korrekta åtgärder/behandling/handläggning	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 13

Du är underläkare på lungavdelningen. Du har precis rondat en patient som under natten blivit inlagd på grund av andningsbesvär.

Du ska:

- **Utifrån inläggningsjournal** (finns här nedanför)
  lab-lista samt läkemedelslista (finns inne på rummet)
  göra en överrapportering till din överläkare enligt SBAR

<u>Inläggningsjournal torsdag 2023-04-26 03:00</u>

Inkommer på grund av andnöd.

Patient med KOL som kommer på grund av svår andnöd. Ökade besvär med andningen sedan igår, inte kunnat ligga ner, missfärgade upphostningar. Förnekar bröstsmärta. Enligt ambulansjournal samtalsdyspné, allmänpåverkad och subfebril. Saturation 76%. Erhåller i ambulansen inhalation Combivent (salbutamol+ipratropium) och 8 tabl Betapred 0,5 mg (betametason).

Status:

Allmäntillstånd: Magerlagd, intorkad, temp 37,8 °C. Inga pittingödem på underbenen.

Cor: Normofrekvent regelbunden rytm. Blodtryck 135/71 mm Hg. Puls 91 /minut.

Lungor: Generellt tysta andningsljud över hela lungfälten, framför allt höger lungfält. En del sonora ronki. Saturation 91% på 1L O_2.

Bedömning: Andnöd hos patient med KOL

Provsvar och läkemedelslista finns inne på rummet

Station 13 Lungmedicin - SBAR KOL-exacerbation, 26/04/2023 TEST 6 min Candidate:

Situation och Bakgrund	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Titel, namn	1	0.5	0
Andningsbesvär KOL	1	0.5	0
Aktuellt	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Akuta symtom som vid KOL-exacerbation (andnöd, missfärgade upphostningar)	1	0.5	0
Koldioxid retention	0.5	- NA -	0
Differentialdiagnoser: Pneumoni, lungemboli, pneumothorax, covid	0.5	- NA -	0

Rekommendation	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Betapred 4-8 mg po eller iv eller motsvarande	0.5	0
Bronkdilatation salbutamol 5 mg/ipatropium 0,5 mg x 4 eller motsvarande.	0.5	0
Sänk syrgas till 0,5 L och/eller ny blodgas	1	0
Antibiotika	0.5	0
Lungröntgen (DT thorax, DT pulmonalisangio)	0.5	0
Sputumodling	0.5	0
Nasopharynx-sekret virus	0.5	0
Övergripande	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Koncist	0.5	0
Strukturerat	0.5	0
Förståeligt	0.5	0
Professionellt	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 14

En tidigare väsentligen frisk patient kommer till dig på hälsocentralen på grund av sömnproblem.

En läkarstudent har undersökt patienten innan du träffar den:

Status:
Cor: Jämn rytm, inga bi- eller blåsljud
Pulm: Rena andningsljud
Blodtryck: 130/75 mmHg

Du ska:

- **Ta anamnes**
- **I samråd med patienten planera fortsatt handläggning**

Station 14 PU - Patient med sömnbesvär, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Lyssnar in patientens oro och kan på ett empatiskt sätt visa hur svårt detta är för patienten. Tillfredsställande: Lyssnar in oro och önskan (om läkemedel bla) samt ger kvitton Delvis tillfredsställande: Lyssnar huvudsakligen automatiserat, ger endast sparsam återkoppling och få eller inga kvitton. Tex kan lyssna in oro, men inte önskan. Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften, går förbi patientens situation.	2	1	0
Frågar upp om patienten provat någon egen strategi gällande sömnen. Tillfredsställande: Frågar upp om patienten gjort några egna åtgärder för att sova bättre. Ej tillfredsställande: Frågar ej upp om patientens egna strategier.	1	- NA -	0
Förklarar varför utredning är viktigt Tillfredsställande: Förklarar varför utredning är viktigt på ett tydligt och patientcentrerat sätt (uppnå samförstånd). Delvis tillfredsställande: Tar upp att man bör göra utredning/påbörjar utredning men ger ej fullgott svar på varför eller vissa brister i patientcentreringen. Ej tillfredsställande: Förmår ej ge rimlig förklaring för patienten, uppträder ej patientcentrerat.	2	1	0
Initierar utredning för att utesluta somatiska orsaker till sömnproblemen tex prover relevanta för sömnutredning, utökad anamnes tex föreslår sömndagbok till nästa besök. Tillfredsställande: Berättar för patienten att denne tänker initiera utredning. (1p) Ej tillfredsställande: Tar ej upp utredning så som tex provtagning som del i utredning(0p)	1	- NA -	0
Frågar upp om följande (minst 3-4st ger 2p, om 1-2st 1p om ingen av dessa 0 p) Frågar upp om psykiskt hälsa, (tex depressivitet, ångest och liknande. Frågar upp om psykosocial situation (tex situation på arbetet, våld i hemmet.) Frågar upp om alkohol och drogbruk. Frågar om snarkning	2	1	0
Föreslår en plan som inkluderar ett återbesök/upprepad kontakt. Tillfredsställande: Föreslår en plan som inkluderar återbesök/upprepad kontakt för uppföljning och vidare utredning. Ej tillfredsställande: Missar att planera för uppföljning och vidare utredning	2	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 15

Du arbetar som underläkare på en kirurgavdelning och ska ronda en patient som har en trachealkanyl sedan flera veckor. Patienten har varit vårdad på IVA med respiratorisk insufficiens efter hemikolektomi och sepsis. Patienten är överviktig, ödematös och har en kuffad kanyl.

Du ska:

- **Genomföra gårond**

Station 15 ÖNH - Stopp i trachealkanyl, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten tar bort luftfuktaren och innerkanylen	1	0
Studenten larmar	1	0
Studenten suger rent	2	0
Studenten kuffar ur och tar ut hela kanylen	2	0
Studenten sätter in en ny kanyl/håller luftvägen öppen med ett nässpekulum	2	0
Studenten kan ange en rimlig förklaring till varför det kan vara stopp i kanylen. (dislocerad/framför trachea, granulationsvävnad i spetsen, koagel i trachea vid kanylen)	1	0
1p för rätt ordning (moment 1 +2 före 3 före 4 före 5)	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 16

Lo, 50 år gammal kommer till dig på hälsocentralen på grund av besvär med händerna. Det har varit besvärligt med klåda och utslag sedan flera månader tillbaka.

Du ska:

- **Ta en relevant anamnes**
- **Berätta högt vad du ser i hudstatus** (utifrån bild)
- **Informera Lo om mest trolig diagnos, möjliga orsaker och vidare handläggning**

Du ska INTE undersöka patienten.

Station 16 Dermatologi - utslag på händerna, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes	2	1	0
Diagnos	1	0.5	0
Handläggning	2	1	0
Frågor och farhågor	2	1	0
Kommunikation	3	1.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 18

En 35-årig man kommer till akutmottagningen på grund av tilltagande svaghet och domningar i armar och ben sedan 10 dagar. Han har inte slagit sig, är helt vaken och är uppegående med vissa svårigheter. Inga andningsbesvär.
Från triagen får du veta att han har bra blodtryck och puls samt är afebril.

Du ska:

- **Utföra relevanta delar av rutinnervsstatus**
- **Informera patienten om var skadan troligen sitter, samt vidare handläggning**

Du ska INTE ta anamnes eller undersöka grad av pareser

Station 18 Neurologi - Förlamning på akuten, 26/04/2023 TEST 6 min **Candidate:**

Nervstatus	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Undersöker något av ansiktsmotorik eller ögonmotilitet	1	- NA -	0
Undersöker reflexer alla fyra extremiteter (1 reflex per extremitet räcker)	2	- NA -	0
Undersöker känsel för stick och vibrationssinne enligt rutinnervstatus	1	0.5	0
Undersöker om nivå för känsel finns på bålen	2	- NA -	0
Kontrollerar Babinskis tecken (tops/tandpetare krävs för poäng)	1	- NA -	0

Bedömning	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Korrekt nivåbedömning (ryggmärgsskada)	2	0
Korrekt remiss för magnetkameraundersökning av ryggmärgen	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**